Réponses aux Demandes du Comité Stratégique de Vivalia

Document B2B

Version 1.0
19 February 2024

Dim3
Rue de Louveigné 188/d
4052 Beaufays
Belgium
Tel: + 32 4 252 35 00
www.dim3.com

Historique de versions

Version	Date	Author	Content
1.0	19/04/2024	JC Havaux	Original

Table des matières

Historique de versions 2
Table des matières 2
1 Ligne du temps 3
2 Projet Co Creation Vivalia - Dim3 4
2.1 Description du projet 4
2.2 Principe du projet 4
2.3 Description projet Vivalia et attentes produit Dim3 4
3 Impact Financier Presenti 7
4 Dossier Remis à Wallonie Santé 8
5 Réponses aux Questions de Monsieur Bernard 8

Confidential, do not copy or distribute

1 Ligne du temps

2017
Dim3 et Vivalia entament une relation de collaboration (Dr Mokkadem/ Mme Pirson) portant sur les produits développés par Dim3 (Scorso/Nutrow/Feedim) et ceux développés ou en projet chez Vivalia en ISU ou autres départements (Nutriscope). La collaboration se traduit en partage de vision opérative et de développement ainsi que la collaboration sur un mémoire de fin d'étude réalisé chez Vivalia.

2017- 2021
Maintien des contacts avec fréquentes présentations des avancées de Dim3 avec le Dr Mokkadem et Mme Pirson.

11/2/2021
Présentation de la plateforme Dim3 à Mr Lespagnard en coordination avec Madame Pirson en présentant les gains pressentis au niveau remboursement pour Vivalia.

En fonction de cette présentation, Mr Lespagnard demande à Mme Pirson et au Dr Lemaire d'analyser les gains potentiels en fonction de la réelle situation des dossiers.

5/12/2022
Le Dr Lemaire émet le rapport demandé.

15/12/2022
Réunion avec La direction et Mr LEspagnard pour discuter des observations de Vivalia et définir les grandes lignes d'une collaboration.

22/2/2023
Signature d'une Letter of Intent entre Vivalia et Dim3.

5/4/2023
Réunion chez Wallonie Santé de présentation du projet Vivalia/Dim3 en présence de ING. Accord de principe acquis.

22/5/2023
Réunion d'alignement avec les participants Vivalia Dim3.

7/11/20223
Réunion Dim3/ Département IT Vivalia **(**Philippe Depierreux**,** Thomas Debiève**,** Jean-Yves Colle).

21/11/2023
Envoi du dossier de projet à Wallonie Santé, co-signé par Vivalia.

17/1/ 2024
Perte d'alignement.

Confidential, do not copy or distribute

2 Projet Co Creation Vivalia - Dim3

2.1 Description du projet

Nous reprenons ici les idées de base yant amené la rédaction d'une demande de soutien financier à Wallonie Santé.

En partenariat avec différents acteurs du secteur Dim3 a développé le concept de co-création.

La Co-Création est destinée à accélérer les validations des sociétés innovantes en MedTech qui tout en ayant des produits finalisés se heurtent à la faisabilité d'une validation client. Hélas, les hôpitaux ne disposent pas des ressources financières et humaines pour participer à la validation client.

Ceci handicape fortement le secteur MedTech qui se voit ainsi freiné dans la commercialisation de ses solutions.

La solution de co-création que nous proposons serait une première en Belgique, voire en Europe, et nous proposons de le démontrer par un partenariat Vivalia/Dim3.

2.2 Principe du projet

Vivalia et DIM3 s'associent dans un contrat de partenariat afin d'utiliser en routine les produits DIM3 déjà existants, marqué CE et répondant aux normes de cybersécurité. L'objectif est de documenter les bénéficies globaux pour Vivalia. Le but est d'analyser les impacts positifs et les répercuter dans tout le parcours de soins des patients en routine.

L'objectif de ce projet est de permettre à Vivalia de disposer d'un outil Medtech existant de nouvelle génération permettant d'allier économies et gains financiers substantiels tout en augmentant la qualité de vie des patients.

L'objectif de ce projet est de permettre à Dim3 de valider internationalement sa plateforme pour accélérer les temps de commercialisation.

L'objectif de ce projet est de permettre à Dim3 et Vivalia de créer des outils de connexion de données spécifiques aux besoins de Vivalia dans l'objectif d'une automatisation accrue du contenu DPI et liens RHM

L'objectif de ce projet pour les partenaires est de disposer internationalement d'un centre de référence permettant d'accroitre la visibilité des partenaires à l'extérieur (Belgique, France, Allemagne)

Dans le cadre de ce projet, Dim3 serait le Coordinateur de la mise en place de sa plateforme de gestion nutritionnelle dans le respect de la norme ISO13485.

S'agissant d'un projet d'innovation, le financement potentiel par les autorités impliquées dans la santé peut être déclenché avec notamment Wallonie Santé et ING en accord avec le principe du projet.

2.3 Description projet Vivalia et attentes produit Dim3

Confidential, do not copy or distribute

2.3.1 CHAMP D'APPLICATION POUR VIVALIA

- Outils de gestion de la nutrition clinique par l'équipe d'experts de Vivalia en nutrition
- Facteur de différenciation pour Vivalia par la digitalisation utile pour les utilisateurs et les patients dans tout le parcours de soins
- Outils numériques efficaces et évolutifs pour tout le groupe Vivalia
- Preuve et atouts économiques avec l'objectif d'augmenter le remboursement ou réduire les couts.
- Poursuite et continuité du suivi nutritionnel des patients en MRS et en HAD

2.3.2 ACTIFS POTENTIELS POUR VIVALIA

- Aide à la décision en nutrition clinique améliorant le travail des équipes et du CLAN
- Personnalisation accrue pour l'utilisateur et le patient
- Suivi personnalisé du patient
- Remboursement documenté auprès SPF etc
- Image de marque en cas de succès
- Meilleur service perçu par les patients
- Exposition internationale avec les activités de Dim3 en tant que centre de référence

2.3.3 PHASAGE DU PROJET

PHASE 1 : Intégration Pilote et feedbacks utilisateurs (durée 15 mois)

Préparation

- Définition mode d'organisation et organes de support et gestion
- Préparation technique et régulatoire

Actions

- Analyse de l'impact économique sur les remboursements
- Analyse du parcours des données RHM de nutrition
- Intégration produits Dim3:
  - Mise en Place de Scorso, application de détection de la malnutrition dans un service (à définir avec Vivalia)
  - Mise en place de Nutrow et Feedim, application de gestion clinique de la nutrition et électronique de capture des données des pompes d'alimentation dans un service de soins intensifs (à définir avec Vivalia, Libramont pressenti)
- Connecteurs Vivalia (DPI, DII, LIMS...) des produits Dim3
- Analyse intégration procédure Nutriscope + Scorso + Nutrow
- Intégration automatique avec RHM
- Le faire dire, le faire savoir

Rapports

- Utilisation du produit par les utilisateurs (Usability)
- Rapport sur l'impact financier pour le groupe Vivalia
- Rapport sur les points à améliorer ou à innover

PHASE 2 : Améliorations et extension dans l'hôpital et vers le suivi à la maison (durée 15 mois, à financer)

- Intégration Nutriscope + Nutrow

Confidential, do not copy or distribute

- Amélioration produits Dim3 suite aux recommandations phase 1
- Préparation des architectures IT pour extension hors hôpital
- Intégration Dim3 Cuisine-Homecare-Maison de repos

2.3.4 ACCORD DE PARTENARIAT

Vivilia et Dim3 ont signé une lettre d'intention portant sur le partenariat pour :

« Installer le portefeuille DIM3 dans TOUT le groupe Vivialia, étape par étape, utilisé en routine par les utilisateurs. »

Après une période d'utilisation à définir :
- Rapport d'acceptation du produit par les utilisateurs (infirmières/diététiciennes/médecins/CFO/ DIrecteurs...).
- Rapport sur l'impact financier pour le groupe Vivialia.
- Rapport sur les points à améliorer ou à innover

SI LES RÉSULTATS SONT POSITIFS
- Vivalia centre de référence pour la commercialisation internationale de Dim3
- Communication internationale sur la collaboration
- Publication scientifique avec notre comité scientifique
- Utilisation de notre portefeuille produit à prix coûtant ou autre formule

2.3.5 FINANCEMENT DU PARTENARIAT

Principe directeur : financement du projet par source externe

PHASE 1 - Intégration Pilote et feedbacks utilisateurs
- Dim3 fournit les produits, l'installation, la formation et la maintenance/débogage.
- Vivalia intègre étape par étape l'utilisation du portefeuille Dim3.
- Le budget est établi sur une base de couts globaux

UTILISATION EN ROUTINE
Dim3 s'engage à maintenir l'outil en place dans le groupe Vivalia pour une somme forfaitaire représentant les dépenses de Dim3 pour le maintien de l'outil. La somme non supérieure à 50.000 euros annuels sera définie lorsque des éléments de calculs seront disponibles. Dans ce cadre, les données anonymisées seront disponibles pour les projets de recherche en IA de Dim3 en partenariat avec Vivalia.

FONDS DE RECHERCHE
S'agissant d'un projet d'innovation, le financement potentiel par les autorités impliquées dans la santé peut être déclenché avec par ordre de priorité :
- Région Wallonne
- Sogepa Wallonie Santé
- Partenariat ABDH
- Fondations
- Autres

Confidential, do not copy or distribute

3 Impact Financier Presenti

REMARQUE : l'impact financier pressenti ne se réfère pas à la qualité du travail des équipes en aval et amont des soins patients et RHM.

L'impact financier est analysé sur l'apport que les produits informatiques de Dim3 peuvent apporter comme automatisation des transferts de données concernant l'état de malnutrition dans le DPI et vers le RHM.

Les autres impacts financiers et patients (taux de réadmission, réduction longueur de séjour) difficiles à évaluer pour le moment sont estimés globalement dans un fichier Excel ROI Nutrow disponible et annexé au mail envoyé à Vivalia en même temps que ce document.

A la suite d'observations chiffrées dans différents hôpitaux, notamment l'hôpital Erasme sous la coordination de Mme Farine, il est apparu que les hôpitaux omettent d'inclure systématiquement l'état de malnutrition du patient dans le DPI.

Cet oubli dû notamment aux difficultés de transmission de données multi logicielle s'avère être une perte financière non négligeable.

Il ne s'agit pas ici de l'enveloppe lutte contre la malnutrition attribuée aux hopitaux démontrant une politique de lutte contre la malnutrition mais bien d'un impact direct sur le remboursement via la procédure RHM.

La présentation faite le 11/2/21 est également jointe au mail envoyé en même temps que ce document.

Confidential, do not copy or distribute

4 Dossier Remis à Wallonie Santé

Voir fichier en pièce jointe au mail envoyé en même temps que ce document.

5 Réponses aux Questions de Monsieur Bernard

1. Il me semble que le Dr MOKHADEM avait mis en place un tel projet historiquement aux CHA
[Dim3] Il s'agit peut-être d'un projet lié aux ISU ? Quant à la collaboration prévue elle incorpore l'intégration de certaines procédures inclues dans Nutriscope, développé par Vivalia dans OmniPro.

2. J'aurais sollicité l'expertise du Dr LEMAIRE pour valider un impact pour VIVALIA
[Dim3] Question pour Vivalia Interne
a. Je constate que ce rapport existe (cfr échange de mails)
b. Pouvez-vous le réclamer et me faire suivre le rapport du Dr LEMAIRE

3. Impact financier
a. Voir le nombre de séjour qui sont concernés par ce type de diagnostic
b. Calculer le gain potentiel en lits
c. Calculer le gain potentiel
[Dim3] Le rapport du Dr Lemaire relatif à la gériatrie peut être utile

- **Si tous les hôpitaux en font de même, gain = 0 donc perte à concurrence de l'investissement et de la maintenance**

[Dim3] Normalement l'impact financier provient du calcul du remboursement où il manque les données ICD10 de malnutrition (ICD11 sera plus détaillé sur ce point). Il ne s'agit donc pas d'une enveloppe à consommer par les bons élèves mais bien d'un impact systémique sur le calcul de remboursement et durée de séjour remboursable.

- **Pour vérifier l'impact positif sur le BMF, il fauxdrait prouver que nos enregistrements ne sont déjà pas optimisés.**

[Dim3] Ils ne le sont apparemment pas d'après le rapport du Dr Lemaire et le gain pourrait être substantiel.
Dr Lemaire : « On voit que le travail actuel de l'équipe nutritionnelle et le codage des malnutritions apporterait aujourd'hui près de 1.000.000 d'euros et qu'en augmentant le screening à plus de patients on pourrait améliorer le B2 de près de 800.000 euros supplémentaires »

- **Il est mentionné que la rentabilité est intéressante dans les chiffres :**
  - Quel document ?
  - Quelle page ?
  - Quelle rentabilité ?

[Dim3] Voir rapport du Dr Lemaire et données résumées autres hôpitaux (voir la partie 4 de ce document)

4. PP
[Dim3] Dim3 ne semble pas disposer de ce document à moins que ce soit le rapport du Dr Lemaire.

a. page 4
Si durée séjour réelle < DMN : gain pour l'hôpital

Confidential, do not copy or distribute

1. Performant, OUI, gain, pas nécessairement
2. Il fauxt pour cela que l'hôpital soit plein et que le patient qui sort est remplacé par un nouveaux patient

b. Page 8

3'000 points soit 3'000 jours soit +/- 12 lits justifiés (12X2,5X30'000 = 900'000 EUR)
Comment passe-ton à 1'800'000 EUR ???
[Dim3] Dans le dossier remis à Wallonie Santé, la somme annoncée est de 700.000 euro. Dans notre exemple on ne considère pas les données uniquement concernant les points mais les impacts statistiques sur taux de réadmission et diminution séjour des mal nourris suivis.

5. Fichier XLS

a. Situation de nos hôpitauxx à simuler
b. Vous disposez des données ?

[Dim3] Voir fichier en annexe du mail

Confidential, do not copy or distribute